

住院醫師甄選：虛擬還是實體面試？

NEJM Clinical Decisions 互動辯論

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-11

NEJM 2026;394(21)

[原文連結 \(DOI\)](#)

這是什麼文章

- *NEJM Clinical Decisions*：互動式專欄，先給情境，再由兩位專家**被指派**論述兩個選項，讀者投票形成社群意見。
- 非臨床問題，而是 **畢業後醫學教育 (GME)** 的**政策**議題。
- COVID-19 後，住院醫師甄選面試該維持**全虛擬**還是回歸**實體**？
- **兩個選項皆無對錯** — 重點在權衡。

情境：新任住院醫師訓練計畫主任

- 你是某住院醫師訓練計畫的新任主任。
- 2020 疫情前全為實體；疫情後全面虛擬。
- 師長/住院醫師意見分歧。
- 下一輪招生：**繼續全虛擬**，還是**回歸實體**？

選項一

維持全虛擬面試

選項一：維持全虛擬（O'Malley & Voy）

- **降低成本/負擔**：實體耗時耗錢；申請者可能花數千美元旅行。虛擬降低時間、金錢、機會成本。
- **環境**：全虛擬一季可省「100 棵樹苗 10 年」的溫室氣體。
- **官方 + 品質**：**AAMC** 仍建議虛擬；維持決策品質與媒合率。
- **申請者滿意**：七專科評估，**83–89%** 同意虛擬能展現優勢、建立連結、回答問題。
- **缺點與對策**：較難評估契合度/文化/地點 → 一對一接力、即時虛擬查房、3D 環境、改善網站。
- **折衷**：全虛擬 + 排序後選擇性實體參訪；**NRMP 2026** 在內科/小兒/血管外科試辦。

應持續創新最大化虛擬好處，而非全面回歸實體。

選項二

回歸實體面試

選項二：回歸實體 (Richardson & Corbelli)

- **不利小型/偏鄉，威脅公平**：虛擬不成比例嘉惠頂尖大型計畫。
- **規模數據**：大型計畫 (>100 人) **42%** 認為虛擬足以排序；小型 (≤100) 僅 **16%**；整體 <40% 認為申請者獲足夠資訊。
- **偏鄉**：平均僅 32 名訓練者；偏鄉受訓者日後偏鄉執業機率高 **5 倍**；虛擬縮短申請者-住院地距離，恐再傷偏鄉。
- **外科**：多數骨科計畫主任偏好實體 (憂虛擬偏袒頂尖申請者)。
- **申請通膨**：十年間申請數翻倍；「面試囤積」；signals 效果未量化、恐惡化。
- **整體審查負擔**：平均 799 份申請需 **3 個月全職**；虛擬恐讓人被網路/裝潢評斷，不利低社經與 URiM。

回歸實體應緩解申請通膨與囤積，保護小型/偏鄉/弱勢申請者。

兩方論點並排

面向	全虛擬	回歸實體
成本/負擔	大幅降低	高，但評估較佳
環境	顯著減碳	旅行碳排
公平性	減少財務障礙	保護小型/偏鄉/弱勢
契合度評估	較難，靠科技彌補	較佳
申請通膨/囤積	可能加劇	應可緩解
官方立場	AAMC 建議虛擬	外科主任多偏好實體
折衷	全虛擬 + 選擇性參訪、NRMP 試辦	—

延伸思考

讀書會討論觀點。

- 典型「**效率 vs 公平/契合度**」權衡，沒有單一正解。
- 大型計畫滿意虛擬、小型不滿意 → 政策不該一體適用，或需**分層/混合**。
- 折衷模式（全虛擬 + 排序後選擇性參訪）試圖兼得，值得關注 **NRMP 2026** 試辦結果。
- 對台灣：甄選文化與地理尺度不同，但「申請通膨 / 弱勢公平 / 契合度」的核心張力共通，可供科部招募與教學參考。

Take-home

- ① 這是 GME 政策辯論，**兩選項皆無對錯**。
- ② 全虛擬贏在**成本、環境、財務公平**；實體贏在**契合度、保護小型/偏鄉/弱勢、抑制申請通膨**。
- ③ 折衷方向：全虛擬面試 + 排序後選擇性實體參訪。

參考文獻

1. Gorey S; O'Malley C, Voy C; Richardson A, Corbelli J. Virtual-Only or In-Person Interviews for Residency Applicants (Clinical Decisions). *N Engl J Med.* 2026;394(21):2160-2162.
2. Daniel M, et al. Virtual interviewing for GME recruitment: a BEME systematic review (Guide No. 80). *Med Teach.* 2022;44:1313-1331.
3. Catalanotti JS, et al. Rethinking the IM residency application process (AAIM consensus). *Am J Med.* 2024;137:284-289.
4. O'Connor AB, et al. Multicenter study of optional in-person visits after virtual interviews. *J Grad Med Educ.* 2023;15:692-701.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件為讀書會共筆整理，僅供教學參考